血管穿刺行為における痛みとしびれの時間差について

23 件の医療訴訟判決文の分析から

◎吉田 淳一郎[1)]、天野 剛介[1)]、稲吉 雅美[1)]、足立 郁美[1)]、野口 和希子[1)]

岡崎市民病院[1)]

【背景と目的】採血や静脈路確保は日常的に行われる手技であるが、神経損傷や CRPS などの合併症が報告されており、医療紛争につながる場合がある。今回、静脈採血や静脈路確保など(以下、穿刺行為)で合併症が発生し、患者が病院や診療所など(以下、穿刺施設)を訴えた事件について、穿刺行為により患者に痛みとしびれが生じた場合、穿刺施設側が患者の痛みとしびれを認識し得た時期と割合について調べた。【方法および対象】裁判所ウェブサイトおよび LEX/DB インターネットを用いた。検索式は(採血 OR 点滴 OR 静脈路 OR 注射 OR 留置針)AND(神経 OR CRPS OR カウザルギーOR 合併症 OR 後遺)とした。検索期間は指定しなかった。事件の経緯が詳細に記載される第一審のみ(23 件)を対象とした。対象判例の判決日は 1996 年 5 月～2024 年 10 月であった。【結果】痛みについては 23 件中、1 件で施設側が認識し得た時期が不明であった。不明例を除く 22 件中、穿刺行為中に施設側が患者の痛みを認識し得たものは 77.3%(17/22 件)、当日中は 81.8%(18/22 件)、3 日以内では 100%(22/22 件)であった。しびれについては 23 件中、8 件で施設側が認識し得た時期が不明であった。不明例を除く 15 件中、穿刺行為中に施設側が患者のしびれを認識し得たものは 20.0%(3/15 件)、当日中は 53.3%(8/15 件)、3 日以内では 73.3%(11/15 件)であった。【考察・結語】痛みは穿刺中 77.3%、3 日以内で 100%施設側が認識し得たのに対し、しびれは穿刺中 20.0%、3 日以内は 73.3%にとどまった。穿刺直後にはしびれとして明確に訴えられず、通常と異なる痛みとして表現される例がある可能性が示唆された。したがって、しびれの有無のみで判断せず、痛みの性状確認や経過観察・受診勧奨が重要と考えられた。なお、本研究は医療訴訟判決文に基づくため、症状表現や認識時期が訴訟上の主張・記録内容の影響を受ける可能性がある。また、症状の出現時期・性状、説明内容、経過観察や受診勧奨の有無を記録することは、神経障害発生時の医療安全上の振り返りに有用であり、医療紛争発生時の事実確認にも重要と考えられた。連絡先―0564-21-8111(代表)